

## Pericarditis y Miocardiopatías

---

### 1. Introducción y relevancia clínica

La **pericarditis** y las **miocardiopatías** son entidades distintas pero estrechamente relacionadas:

- La **pericarditis** es la inflamación del pericardio, la membrana que rodea el corazón.
- Las **miocardiopatías** son enfermedades primarias del músculo cardíaco, que alteran su función contráctil o estructural.

Ambas pueden causar **dolor torácico, disnea o signos de insuficiencia cardíaca**, y su diagnóstico temprano es crucial para evitar complicaciones como **taconamiento cardíaco o muerte súbita**.

En Chile, las etiologías más frecuentes de **pericarditis** son las **virales (enterovirus, influenza, adenovirus)**, seguidas por las **idiopáticas**, que en la práctica se tratan igual. Entre las **miocardiopatías**, predominan la **dilatada** y la **hipertrófica**, ambas con implicancias pronósticas y hereditarias relevantes.

En el **EUNACOM**, estos temas suelen presentarse en casos clínicos de **dolor torácico atípico, ECG con elevación difusa del ST, o disnea progresiva en jóvenes sin cardiopatía previa**.

Las claves son reconocer los patrones electrocardiográficos, las diferencias con el infarto, y el manejo médico o quirúrgico indicado.

---

### 2. Fisiopatología y bases conceptuales

#### 2.1. Pericarditis

El **pericardio** tiene función de protección mecánica y lubricación. Está compuesto por dos capas (visceral y parietal) separadas por una pequeña cantidad de líquido seroso (15–50 mL).

La **pericarditis** se produce por inflamación de estas capas, con o sin derrame pericárdico.

#### Etiologías principales

- **Virales**: coxsackievirus, echovirus, influenza, adenovirus (más frecuentes).
- **Idiopática**: diagnóstico por exclusión, clínicamente indistinguible de la viral.
- **Bacteriana o tuberculosa** (en inmunodeprimidos o zonas endémicas).
- **Autoinmunes**: lupus, artritis reumatoide.

- **Neoplásica:** metástasis pulmonares, mama o linfomas.
  - **Postinfarto o postquirúrgica (síndrome de Dressler).**
  - **Uremia, hipotiroidismo o radioterapia.**
- 

## 2.2. Miocardiopatías

Son enfermedades del **miocardio** que afectan su estructura o función, en ausencia de enfermedad coronaria, valvular o hipertensiva significativa.

**Clasificación (ESC 2023):**

1. **Miocardiopatía dilatada (MCD):** dilatación del VI con disfunción sistólica.
  2. **Miocardiopatía hipertrófica (MCH):** engrosamiento desproporcionado del VI, generalmente por mutación genética.
  3. **Miocardiopatía restrictiva (MCR):** rigidez del miocardio con llenado diastólico reducido.
  4. **Miocardiopatía arritmogénica del VD (MAVD):** reemplazo fibrograso del ventrículo derecho.
  5. **Miocarditis:** inflamación del miocardio, muchas veces viral, que puede evolucionar a MCD.
- 

## 3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

### 3.1. Pericarditis aguda

**Síntomas característicos**

- **Dolor torácico pleurítico** (punzante o urente), **empeora al inspirar o al acostarse y mejora al inclinarse hacia adelante.**
- Puede acompañarse de **fiebre, malestar general y tos seca.**
- En casos con derrame significativo, aparece **disnea** o sensación de “peso torácico”.

**Examen físico**

- **Roce pericárdico:** sonido áspero, “de cuero nuevo”, mejor auscultado en borde esternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante.
- Si hay **derrame importante**, los ruidos cardíacos se atenúan.
- En **taponamiento cardíaco**, aparecen signos de compresión:
  - **Ingurgitación yugular,**
  - **Pulso paradójico** (>10 mmHg de caída de la PA sistólica en inspiración),
  - **Hipotensión y ruidos cardíacos apagados** (tríada de Beck).

**Comentario EUNACOM:**

Paciente joven con **dolor torácico que mejora al inclinarse hacia adelante y elevación difusa del ST en el ECG** → diagnóstico: pericarditis aguda.

---

### 3.2. Miocardiopatías

#### Miocardiopatía dilatada (MCD)

- Síntomas de **insuficiencia cardíaca**: disnea, ortopnea, edemas, fatiga.
- Palpitaciones y **taquiarritmias** (FA o taquicardia ventricular).
- En casos avanzados, **hepatomegalia y ascitis**.

#### Miocardiopatía hipertrófica (MCH)

- Disnea de esfuerzo, **angina y síncope**.
- Puede presentarse con **muerte súbita** en jóvenes deportistas.
- Soplo sistólico que **aumenta con maniobras que reducen la precarga** (Valsalva o bipedestación).

#### Miocardiopatía restrictiva (MCR)

- Disnea, edema, ascitis y hepatomegalia con **presión venosa yugular elevada**, pero **ventrículos no dilatados**.
- Causas: amiloidosis, hemocromatosis, sarcoidosis, fibrosis postradiación.

#### Miocardiopatía arritmogénica del VD (MAVD)

- Palpitaciones, síncope o **taquicardia ventricular con morfología de BCRI**.
  - Es causa importante de **muerte súbita en jóvenes**.
- 

## 4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

### 4.1. Pericarditis aguda

#### Electrocardiograma

- Elevación difusa del ST en varias derivaciones (no anatómicas), con **PR descendido**.
- En fases tardías, **inversión de onda T** y normalización posterior.
- Ausencia de patrón recíproco, a diferencia del infarto.

#### Ecocardiograma

- Evalúa la presencia y cantidad de **derrame pericárdico**.
- Permite descartar **taponamiento cardíaco** o **miopericarditis**.

## Laboratorio

- PCR y VSG elevadas.
- Troponinas levemente aumentadas si hay compromiso miocárdico.
- En pericarditis uremia o autoinmune, exámenes específicos.

## Criterios diagnósticos (ESC 2023):

Requiere **2 de los 4 criterios**:

1. Dolor torácico típico.
  2. Roce pericárdico.
  3. Elevación difusa del ST o descenso del PR.
  4. Derrame pericárdico nuevo o progresivo.
- 

## 4.2. Miocardiopatías

**Ecocardiograma transtorácico:** examen fundamental.

- **MCD:** cavidades dilatadas, FEVI reducida, hipocinesia difusa.
- **MCH:** hipertrofia asimétrica septal (espesor >15 mm) y gradiente subaórtico dinámico.
- **MCR:** cavidades normales con disfunción diastólica.
- **MAVD:** adelgazamiento del VD, aneurismas localizados.

**RM cardíaca:** confirma infiltración (amiloidosis, sarcoidosis) o fibrosis.

**ECG:**

- En MCH: ondas Q profundas septales.
- En MCD: bajo voltaje o bloqueos.
- En MAVD: ondas épsilon en derivaciones derechas.

**Biopsia endomiocárdica:** en casos seleccionados (miocarditis fulminante, diagnóstico incierto).

---

## 5. Tratamiento (según guías ESC/AHA/MINSAL)

### 5.1. Pericarditis aguda

**Objetivos:** aliviar dolor, controlar inflamación y prevenir recurrencias.

**Tratamiento médico**

1. **Reposo y restricción de actividad física** hasta resolución clínica y normalización de marcadores.
2. **Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs):**
  - Ibuprofeno 600–800 mg cada 8 h o Aspirina 750–1000 mg cada 8 h por 1–2 semanas.
  - Reducir dosis progresivamente.
3. **Colchicina:** 0,5–1 mg/día por 3 meses (reduce recurrencias).
4. **Corticoides (prednisona 0,2–0,5 mg/kg/día)** solo si refractaria, autoinmune o postradiación.
5. **Evitar anticoagulantes** si hay derrame importante (riesgo de taponamiento).

#### Tratamiento del derrame/taponamiento

- **Pericardiocentesis urgente** si hay signos de taponamiento o derrame masivo.
- En derrames leves, control ecográfico periódico.

**Recurrencias:** tratar con AINEs + colchicina; considerar corticoides o inmunosupresores en casos refractarios.

---

## 5.2. Miocardiopatías

### Miocardiopatía dilatada (MCD)

Tratamiento similar a la **insuficiencia cardíaca con FE reducida (ICFER):**

- IECA o ARA II o ARNI (sacubitril/valsartán).
  - Betabloqueadores (carvedilol, bisoprolol).
  - Antagonista de aldosterona (espironolactona).
  - SGLT2i (dapagliflozina).
  - Diuréticos si congestión.
  - Evitar alcohol y cardiotóxicos.
  - En disfunción severa: **DAI o TRC**; considerar **trasplante cardíaco**.
- 

### Miocardiopatía hipertrófica (MCH)

**Objetivos:** aliviar síntomas y prevenir muerte súbita.

- **Betabloqueadores o verapamilo/diltiazem** para reducir la contractilidad y mejorar el llenado diastólico.
  - Evitar diuréticos agresivos y nitratos (reducen precarga y agravan obstrucción).
  - En obstrucción severa refractaria: **miectomía septal o ablación con alcohol**.
  - **DAI** en alto riesgo de muerte súbita (historia familiar, síncope, TV, grosor >30 mm).
- 

### Miocardiopatía restrictiva (MCR)

- Tratar la causa base (amiloidosis, hemocromatosis).
  - Uso prudente de diuréticos para congestión.
  - Evitar vasodilatadores y digoxina (pueden empeorar llenado).
- 

#### **Miocardopatía arritmogénica del VD (MAVD)**

- Restricción de actividad deportiva.
  - Betabloqueadores.
  - **DAI** en pacientes con taquicardias ventriculares o antecedentes familiares de muerte súbita.
  - Ablación o trasplante en casos refractarios.
- 

## **6. Complicaciones y pronóstico**

#### **Pericarditis:**

- **Recurrencia crónica** (en 15–30 % de casos).
- **Taponamiento cardíaco.**
- **Pericarditis constrictiva crónica:** engrosamiento pericárdico que limita el llenado diastólico, requiere **pericardiectomía**.

#### **Miocardopatías:**

- **Insuficiencia cardíaca avanzada.**
- **Arritmias ventriculares y muerte súbita.**
- **Tromboembolismo** (especialmente en MCD con FEVI <35 %).
- **Progresión a trasplante cardíaco.**

El pronóstico varía según la etiología y la respuesta al tratamiento.

Las formas virales suelen ser benignas, mientras que las genéticas o infiltrativas pueden evolucionar desfavorablemente.

---

## **7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM**

#### **Perlas:**

1. Dolor torácico que **mejora al inclinarse hacia adelante** = pericarditis.
2. **Elevación difusa del ST** en ECG sin cambios recíprocos → pericarditis, no infarto.
3. En **taponamiento cardíaco**, recordar la **tríada de Beck**: hipotensión, ruidos apagados e ingurgitación yugular.
4. **Miocardopatía dilatada** cursa con FEVI baja y signos de IC.

5. **Miocardopatía hipertrófica** se asocia a muerte súbita en jóvenes deportistas.
6. **Betabloqueadores** son el tratamiento base en MCH.
7. En EUNACOM, distinguir entre **dolor pericárdico (pleurítico, posicional)** y **anginoso (opresivo, con irradiación)** es clave.

#### Errores frecuentes:

- Diagnosticar IAM ante un ECG con elevación difusa del ST sin analizar el patrón.
  - No realizar ecocardiograma ante sospecha de pericarditis con derrame.
  - Administrar anticoagulantes en taponamiento.
  - Usar nitratos o diuréticos excesivos en MCH obstructiva.
  - Ignorar el riesgo hereditario en miocardiopatías familiares.
- 

## 8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Pericarditis**: inflamación del pericardio, dolor pleurítico que mejora al inclinarse hacia adelante, ECG con ST difuso.
2. **Tratamiento**: AINEs + colchicina; evitar anticoagulantes en derrames.
3. **Taponamiento cardíaco** = urgencia vital → pericardiocentesis inmediata.
4. **Miocardopatía dilatada**: FEVI reducida, manejo como insuficiencia cardíaca.
5. **Miocardopatía hipertrófica**: riesgo de muerte súbita, betabloqueadores o miectomía.
6. **Miocardopatía restrictiva**: cavidades normales, llenado rígido, tratamiento sintomático.
7. En EUNACOM, la clave está en reconocer **el tipo de dolor torácico, el patrón ECG y la conducta inmediata**.